

Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
« COUSP RDC »
Système de Gestion de l'Incident MVE-17

Rapport de Situation de la 17^{ème} Epidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC
SitRep N°010/MVB 25/2026

Provinces touchées (3)	ITURI, NORD-KIVU & SUD-KIVU
Zones de Santé touchées (13)	ITURI : Aru, Bunia, Kilo, Mongbwalu, Nizi, Nyankunde et Rwampara NORD-KIVU : Butembo, Goma, Oicha, Kalunguta et Katwa SUD-KIVU : Miti-Murhesa
Date de rapportage	24 mai 2026
Date de publication	25 mai 2026

105	10	906	223*	ND	ND	0	ND
Cumul cas confirmés	Cumul décès parmi les confirmés	Cumul cas suspects	Cumul Décès suspects	Taux d'occupation chez les suspects	Taux d'occupation chez les confirmés	Guéris	Cumul cas confirmés CTE

Tableau I. Répartition des cas et décès confirmés par zone de santé dans les provinces touchées en date du 24/05/2026

Provinces touchées	Zones de santé avec cas confirmés	Nouveaux					Guéris du jour
		Cas confirmés	Décès parmi confirmés	Cas probables	Cas suspects	Contacts listés**	
Ituri	Bunia	0	0	ND	ND	0	0
	Rwampara	0	0	ND	ND	0	0
	Mongbwalu	0	0	ND	ND	0	0
	Aru	0	0	ND	ND	ND	0
	Nyankunde	0	0	ND	ND	0	0
	Nizi	0	0	ND	1	0	0
	Kilo	0	0	ND	1	ND	0
Sous total		0	0	0	2	ND	0
Nord-Kivu	Goma	0	0	ND	ND	ND	0
	Butembo	2	0	ND	ND	ND	0
	Katwa	0	0	ND	ND	ND	0
	Oicha***	1	0	ND	ND	ND	0
	Kalunguta***	1	0	ND	ND	ND	0
Sud Kivu	Miti Murhesa	0	0	ND	ND	ND	0
Sous total		4	0	0	0	0	0
Total		4	0	0	2	0	0

* Le rapport du 24 mai comportait une erreur de saisie de chiffres.

** Ces données sont susceptibles de modifications avec l'évolution de réception des données.

*** : Nous n'avons reçu que les résultats de Labo positif sans les autres détails

I. CONTEXTE

La Province de l'Ituri est située au Nord-Est de la République Démocratique du Congo et partage une longue frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Depuis plus de deux décennies, elle est confrontée à une crise humanitaire chronique liées aux conflits armés et des déplacements récurrents des populations. Elle compte une population estimée à plus de 8 millions d'habitants parmi lesquels plus d'un million de déplacés internes.

En septembre 2018, cette province était touchée par une épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévissait dans la province voisine du Nord-Kivu.

La zone de santé de Mongbwalu est l'une des 36 zones de santé de la province de l'Ituri. Considérée comme point de départ de l'épidémie elle est située dans le territoire de Djugu où opèrent plusieurs groupes armés. Elle est située à 70 km de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, avec des mouvements fréquents des populations vers l'Ouganda. Cette localité a une particularité d'avoir plusieurs chantiers qui attirent les populations venant des autres territoires de la province et des provinces voisines.

II. HISTORIQUE DE L'EPIDEMIE

En date du 05 mai 2026, les réseaux sociaux déclarent une flambée de décès de cause inconnue avec près de 50 décès déjà enregistrés dans la zone de santé de Mongbwalu. Après la validation des alertes, le Médecin chef de la zone de santé de Mongbwalu partage le rapport de l'investigation préliminaire le 09 mai 2026. Le 11 mai 2026, les autorités sanitaires provinciales organisent une réunion d'urgence et décident de déployer des équipes d'intervention rapide (EIR) à Mongbwalu et Rwampara qui avaient rapporté des décès suspects de fièvre hémorragique virale chez des malades internés au Centre médical Evangélique de Rwampara, provenant de Mongbwalu.

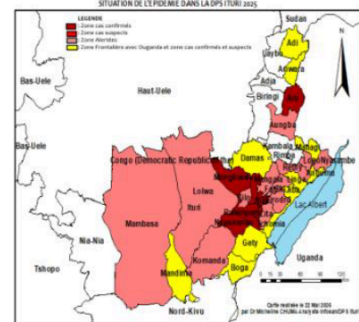
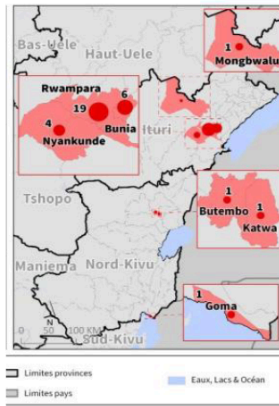
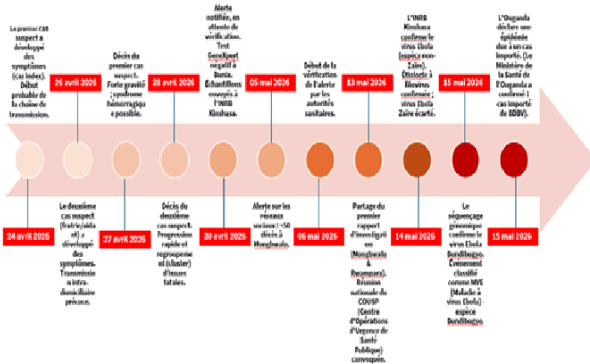
Les investigations menées le 12 mai 2026, simultanément dans les zones de santé de Mongbwalu et de Rwampara par les Equipes d'Intervention Rapide de la Division provinciale de la santé (DPS) de l'Ituri ont permis de relever que la plupart des patients ou décès suspects avaient la fièvre, les céphalées, les vomissements, une asthénie physique intense. Les décès survenaient 2 à 3 jours après le début de la maladie dans un tableau d'hématémèse, épistaxis ou de vomissement noirâtre. Au cours des investigations dans la zone de santé de Rwampara, 20 échantillons sur les cas ou décès suspects ont été effectués. La majorité des personnes prélevées provenaient de la zone de santé de Mongbwalu. Les tests préliminaires effectués au Laboratoire de Bunia étaient tous négatifs pour Ebola zaïre, dengue, Rotavirus, Cholera, Paludisme, Yersinia pestis, mpox et COVID-19. Ces échantillons ont été envoyés à l'Institut National de Recherche Biomédicale (INRB) de Kinshasa pour des examens additionnels.

En date du 14 mai 2026, 13 cas de ces 20 échantillons ont été testés et 8 se sont révélés positifs à la maladie à virus Ebola non-Zaïre à l'INRB Kinshasa. Le 15 mai 2026, le séquençage des échantillons positifs a permis d'identifier la souche BUNDIBUGYO, ce qui a permis au ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale (MSHPS) de déclarer officiellement la 17^{ème} épidémie de la maladie à virus Ebola en République Démocratique du Congo.

En date du 17 Mai 2026, en concertation avec les états membres, le Directeur général de l'OMS estime que l'événement qui se passe en RDC et en Ouganda répondent aux critères de la définition énoncés à l'article 1 du RSI, et a déclaré que cela constitue une Urgence de Santé Publique de Portée Internationale tout en précisant que le risque au niveau mondial est faible mais élevé au niveau régional.

Le 18 mai 2026, le Directeur général du CDC Afrique a officiellement déclaré une urgence de santé publique de sécurité continentale (USPSC) en vertu de l'article 3 de ses statuts. Cette déclaration faisait suite à une réunion d'urgence du groupe consultatif du CDC Afrique, qui a estimé que l'aggravation de l'épidémie constituait un risque aigu pour la sécurité sanitaire continentale. En conséquence, l'équipe continentale de soutien à la gestion des incidents a été activée afin d'apporter son soutien aux États membres touchés et à ceux exposés aux risques, en matière de réponse et de préparation.

CHRONOLOGIE DES EVENEMENTS



III. MISE A JOUR DE LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

- ❑ **Aucun échantillon n'a été analysé en Ituri.**
- ❑ Provinces touchées : ITURI, NORD-KIVU et SUD-KIVU
- ❑ Cumul de cas confirmés 24 mai 2026 : 105 cas dont 94 en Ituri, 10 au Nord-Kivu et 1 au Sud-Kivu
- ❑ ITURI : épiceutre avec 7/36 ZS touchées (Aru, Bunia, Kilo, Rwampara, Mongbwalu, Nizi et Nyankunde)
- ❑ NORD-KIVU : 5/35 ZS touchées (Goma, Butembo, Oicha, Kalunguta et Katwa)
- ❑ SUD-KIVU : 1/34 ZS touchée (Miti-Murhesa)
- ❑ Parmi les 10 décès confirmés, 6 de sexe masculin (dont 5 âgés de plus de 15 ans et 1 de moins de 15 ans) et 4 de sexe féminin (dont 3 âgés de plus de 15 ans et 1 de moins de 15 ans)

IV. ACTIONS DE LA REPONSE REALISEES

IV.1. COORDINATION

- Tenue de réunion stratégique autour du Gouverneur

IV.2. SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE

- Briefing sur le tracking des alertes au niveau de la DPS en incluant les membres de la protection civile (2 personnes) ;
- Réalisation des activités de surveillance sur terrain (remontée des alertes, investigations, recherche active, listage et suivi des contacts, revue documentaire rétrospective des cas et décès, etc) ;

Tableau II. Répartition des cas, décès suspects et confirmés de maladie à virus Ebola dans les zones de santé de la DPS Ituri, Nord-Kivu et Sud Kivu au 24 mai 2026

Provinces	Zones de santé	Nbre de cas suspects	Nbre de décès suspects*	Nbre de cas Confirmés	Nbre de contacts*
Ituri	Aru	4	1	1	0
	Bambu	6	2	0	183
	Bunia	249	48	24	404
	Kilo	8	2	1	0
	Mongbwalu	339	88	19	222
	Nizi	6	2	2	22
	Nyankunde	45	11	9	365
	Rwampara	228	69	32	621
	Echantillons sans fiche	0	0	6	0
Nord-Kivu	Butembo	7	0	3	22
	Goma	0	0	1	28
	Katwa	13	0	4	99
	Karissibi	0	0	0	249
	Kyondo	0	0	0	16
	Oicha**	ND	ND	1	ND
	Kalunguta**	ND	ND	1	ND
Sud-Kivu	Miti Murhesa	1	0	1	ND
Total		906	223	105	2231

*Ces données sont susceptibles de changer après harmonisation des données à différents niveaux de la pyramide sanitaire avec le système de gestion des incidents.

***: Nous avons reçu les résultats positifs de 4 échantillons sans les détails par rapport au nombre d'échantillons reçus et analysés pour la journée du 24/05/2026.

Surveillance aux Points d'entrées et Points de contrôle (PoE/PoC) :

- Activations des 6 PoC : Aéroport, Dele, Mudzibala, Chai et Iga-barrière et Nizi avec appui de l'OIM.

Tableau III. Synthèse de données au PoE/PoC du 24/05/2026

PoE/PoC	TOTAL
Voyageurs passés par le PoE/PoC	11628
Voyageurs screenés	11143
Voyageurs ayant lavés les mains	11413
Voyageurs sensibilisés sur la MVE	11628
Contacts listés	0
Alertes remontées	0



IV.3. LABORATOIRE

- 20 techniciens ont été briefés sur la gestion des déchets avec l'appui de STRIDES ;

Echantillons	Total
Echantillons reçus	431
Ré prélèvements (contrôle)	3
Cumul échantillons analysés	295
Taux de positivité	35,6%
Cumul positifs	105*

*Nous avons reçu les résultats positifs de 4 échantillons sans les détails par rapport au nombre reçu et analysés pour la journée du 24/05



IV.4. PREVENTION & CONTRÔLE DE L'INFECTION

- ❑ Briefing de prestataires des ESS (Clinique KARIBUNI, CITADELLE, CH-UNIBU, CS Adventiste, Polyclinique Limbi Angaika & JESUS EST SAUVEUR CBCA, ... sur la gestion des déchets et le bionettoyage, l'importance d'hygiène des mains, le port d'EPI.
- ❑ Évaluation initiale de score card à la Clinique la RECONNAISSANCE (46%) ; des ESS des AS Jésus est sauveur CBCA (20%), AS Bunia Cité (49%) et CH Rwankole (21%).

IV.5. PRISE EN CHARGE HOLISTIQUE

- Briefing de 32 prestataires de l'HGR Bunia sur la PEC (2 médecins, 8 infirmiers et 22 hygiénistes).
- Réalisation de la cartographie des évadés à partir de listes contenant leurs adresses.
- Démarrage des travaux de construction du CTE à l'HGR Bunia par le partenaire IMC.
- Optimisation des soins effective à l'HGR Bunia et à l'HGR Rwampara.
- Briefing des prestataires de l'HGR Rwampara sur la PEC nutritionnel.
- Réception de 50 boîtes les nourrissons de moins de 6 mois.

Tableau VI. Mouvement des malades dans les établissements de soins en date du 24/05/2026

Indicateurs		HGR Bunia	SOFEPADI	Clinique Bénédicte	CH ELIKYA	CM LES MERITES	CITADELE	UNIBU	CH LA PROVIDENCE	RWAKOLE	CM MATHYSEN	SOUS TOTAL BUNIA	HGR RWAMPARA	CH SALAMA	CME	SOUS TOTAL RWAMPARA	HGR MONGBWALU	HGR NYANKUNDE	HGR BAMBU	HGR ARU	Total
Report (Nbre de malades au lit à la fin de journée précédente)		10	7	2	2	2	7	2	2	8	2	44	7	2	10	19	13	33	2	2	113
Nouvelles Admissions du jour	PPL	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	5
	Autres	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	6	1	1	2	4	5	0	0	0	15
	Total admissions du jour	1	3	0	2	2	0	0	0	0	1	9	3	1	2	6	5	0	0	0	20
Effectif total en isolement		11	10	2	4	4	7	2	2	8	3	53	10	3	12	25	18	33	2	2	133
Cumul de malades admis en isolement		61	13	4	8	4	7	5	2	11	3	118	38	16	ND	54	70	36	0	3	281
Sorties	Guéris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Décédés	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	7	1	0	1	2	1	0	0	0	10
	Cumul des décès	42	6	0	4	1	2	2	2	3	2	64	12	0	24	36	49	1	0	1	151
	Non Cas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
	Evadés	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	2	0	0	0	0	6
	Transférés à HGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2

IV.6. CREC

- Près de 1 735 personnes (294 hommes, 338 femmes, 691 filles, 519 garçons) sensibilisées par les volontaires de la Croix-Rouge au cours des VAD.
- Engagement du chef de la Chefferie de Bahema Irumu à renforcer la sensibilisation de la population de son entité coutumière sur le respect des différentes mesures de la riposte à la MVE. Un message vocal (sonore) a été enregistré en Swahili et en langue locale (Kihema) pour être diffusé à travers différents canaux de communication.
- Parallèlement, le coordonnateur a de la Société Civile Forces Vives de l'Ituri eu enregistré un message vocal à diffuser par à travers les canaux de communication (soutien des actions de riposte par la vulgarisation du communiqué du Gouverneur Militaire sur les différentes mesures préventives de la MVE notamment l'EDS, l'interdiction des veillées mortuaires et le transport des corps sans vie.
- **Levée d'une résistance** à l'EDS brisée après la sensibilisation des membres de la famille éprouvées au Centre Hospitalier UNIBU au quartier Lumumba (ZS Bunia).
- Au cours des différentes cultes des églises catholiques et autres communautés chrétiennes (Bunia et Mahagi), les messages de prévention de la MVE ont été diffusés à l'intention d'un total de 6 700 fidèles.

IV.7. LOGISTIQUE

- Approvisionnement en intrants PCI aux ESS de référence (CSR Lembabo, HGR Kilo, HGR Mogbwalu, HGR Lita).
- Finalisation d'installation de deux tentes de prise en charge à l'HGR Bunia (avec 8 chambres et 8 toilettes)
- Poursuite des travaux d'installation de tentes d'isolement au HGR Rwampara.
- Réception de 330 litres de carburants (Appui FHI360).

IV.8. SECURITE

- La situation sécurité dans la ville de Bunia (ZS de Bunia et Rwampara) est relativement calme
- Briefing sécuritaire aux équipes nouvellement déployées.
- Monitoring de l'incident (incendie d'isolement de HGR Mongbwalu).

V. DEFIS

- **24 heures de rupture en Kits d'analyse RADIONE ;**
- Absence de Centre Transit et Centre de Traitement Ebola normés en Ituri,
- Manque des matériels PCI (EPI, DLM, chlore) au Nord Kivu
- Faible remontée des alertes par les zones dans les 3 Provinces touchées (Ituri, Nord-Kivu et Sud-Kivu) ;
- Insuffisance des ressources financières pour appuyer tous les piliers de la riposte dans les ZS touchées ;
- Difficulté d'acheminements des échantillons vers les laboratoires de Goma et Kinshasa.
- Propagation des rumeurs et prolifération des recettes de traitement traditionnel.
- Absence des supports et outils de communication.
- Faible capacité de diagnostic
- Quantité insuffisante en intrants et réactifs,
- Insécurité dans les zones de santé d'intervention (Incendie de CT de Rwampara, Mongbwalu).

VI. PERSPECTIVES

- Formation des prestataires sur la surveillance de la MVE et la SBC dans les ZS touchées et à haut risque de trois provinces touchées ;
- Formation des Agents communautaires sur la surveillance de la MVE et la SBC dans les ZS touchées et à haut risque de la province d'ITURI.

PHOTOS DE TERRAIN



Poursuite des travaux d'aménagement du CTE Rwampara



Finalisation d'installation de deux tentes de prise en charge à l'HGR Bunia (avec 8 chambres et 8 toilettes)



Séance de travail d'harmonisation des données et production de rapport de situation

**POUR TOUTE
INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE,
VEUILLEZ CONTACTER**

Pour l'Institut National de la Santé Publique (INSP) de la RDC

Le Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Tel. : +243 816 040 145

Le Coordonnateur COU-SP

Prof NGANDU Christian

E-mail : Christian.ngandu@insp.cd

Tél. : +243998091915

L'Incident Manager

Prof Pierre AKILIMALI

E-mail : pierre.akilimali@insp.cd

Tél. : +243815800288

Pour l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS/RDC)

Le Représentant ai de l'OMS en RDC

Dr Anne Marie ANCIA

E-mail : anciaa@who.int

Le Team Lead Cluster EPR de l'OMS en RDC

Dr FOTSING Richard

E-mail: fotsingri@who.int

Pour l'Africa CDC

Justus Nsio Mbete

E-mail : JustusNs@africacdc.org

